

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: PADILLA DAMIAN GENESIS DANIELA	H.C: 1137878833
EDAD: 8 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 15/06/2017
ESCOLARIDAD: Segundo Grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 8,11,13/08/2025
DIRECCION: Cr 13 # 5 – 20	CORREO: <u>carolinahurtadodamian@gmail.com</u>
EPS: Particular	SEXO: F
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3216828310
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Psicología	

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, es muy inmadura para ver la realidad, le cuesta ver la maldad de aquellas personas que le quieren hacer daño, le cuesta identificar lo bueno.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde los primeros años de vida caracterizado, por comportamiento más inocente del esperado a su edad, le cuesta distinguir las intenciones de las demás personas, le cuesta comprender textos complejos, le cuesta recibir ordenes de varias comandos, le cuesta comprender, se frustra, no come carne y pollo, no come ensaladas, madre la describe como muy inteligente, se le dificulta un poco la lectura, codifica de manera rápida, en ocasiones se deja agredir de otras personas – no se defiende, hay palabras que no las pronuncia bien (para decir perro dice pelo), dislalia – rotacismo, no logra dar detalles específicos de eventos, en ocasiones responde con temas que no se relacionan, madre refiere que interactúa bien, es muy cariñosa, en ocasiones hace contacto visual, juega sola, antes lo hacía más, ha mejorado, en ocasiones se aísla, se integra un poco más que en años anteriores, camina en punta de pies, caminaba mucho más que lo evidenciado ahora, más pequeñas cuando se le hacían caritas, no respondía, fue diagnosticada con déficit de atención (TDAH), a los tres años por neuropsicología. Cuando esta encerrada se irrita, llora sin justificación, antes lo hacía con mayor intensidad y frecuencia, en el colegio las profesoras refieren que tiene labilidad emocional llanto fácil, el ruido la irrita – se tapa los ojos ante estos, se enoja si les tocan las cosas, le gusta mucho las cosas pequeñas como fichas, armar, no le gustan mucho los muñecos. Hablo a los 5 años por lo que fue necesario proceso de rehabilitación con fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional.



I. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción: No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

II. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: NO REPORTA.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, adecuada higiene postural, desorientada a lo y orientada auto psíquicamente, bradilalia, bradipsiquia, hiponimia, dislalia – rotacismo, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conación.

PRUEBAS APLICADAS

Se realizó prueba cognitiva Escala de inteligencia de Wscheler para niños V: Atención, Claves del Wisc V, Búsqueda de símbolos del Wisc V: Memoria: Dígitos del Wisc V dígitos en orden directo, inverso y creciente, Span de dibujos del Wisc V, Lenguaje: Semejanzas del Wisc V, Vocabulario, aritmética, letras y números.

Se realizó evaluación neuropsicológica aplicando batería de la ENI 2: 1. Lectura, vocabulario, comprensión.

Se realiza prueba de observación del ADOS 2 que permita conocer la comunicación e interacción social, patrón de comportamiento restrictivo y repetitivo, socialización a partir de: tarea de construcción, respuesta el nombre, juego simbólico, juego interactivo conjunto, conversación, respuesta a la atención conjunta, tarea de demostración, descripción de una imagen, contar una historia de un libro, Juego libre, fiesta de cumpleaños, merienda, anticipación de una rutina con objetos, Juego con burbujas.

Se realiza lista de chequeo CARS con la madre.





ESCALA DE INTELIGENCIA
DE WECHLER PARA NIÑOS - V

Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica
Año Mes Día

Nombre del niño: PADILLA DAMIAN GENESIS DANIELA
Examinador: JAINER GUZMÁN VEGA

Fecha de aplicación: 2025 8 13
Fecha de nacimiento: 2017 6 15
Edad Cronológica: 8 1 28

Página de resumen

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

Prueba	PD	Puntuación escalar					
Cubos	22		10				10
Semejanzas	12	5					5
Matrices	18			11			11
Dígitos	6				2		2
Claves	19					5	5
Vocabulario	8	3					3
Balanzas	19			11			11
Puzles visuales	12		9				(9)
Spam de dibujos	11				4		(4)
Búsqueda de Símbolos	10					5	(5)
Información							(1)
Letras y números	6						(4)
Cancelación							(1)
Comprensión							(1)
Aritmética	8						(4)
Suma puntuaciones escalares		8	19	22	6	10	47
		Comp. Verbal	Visoes-pacial	Razon. Fluido	Mem. Trabajo	Vel. Proces.	Escala total

Perfil de puntuaciones escalares

	Comprensión verbal				visoes-pacial		Razonamiento fluido			Memoria de Trabajo			Velocidad de Procesamiento		
	S	V	I	CO	C	PV	M	B	A	D	SD	LN	CL	BS	CA
	5	3	1	1	10	9	11	11	4	2	4	4	5	5	1
19															
18															
17															
16															
15															
14															
13															
12															
11															
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															

Perfil de puntuaciones compuestas

	ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT
	68	97	106	62	72	76
160						
155						
150						
145						
140						
135						
130						
125						
120						
115						
110						
105						
100						
95						
90						
85						
80						
75						
70						
65						
60						
55						
50						
45						
40						

Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta	Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Comprensión Verbal	8	ICV 68	2	63-80
Visoespacial	19	IVE 97	42	89-106
Razonamiento fluido	22	IRF 106	66	98-113
Memoria de trabajo	6	IMT 62	1	57-73
Velocidad de procesamiento	10	IVP 72	3	66-84
Escala total	47	CIT 76	5	71-83

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Análisis Primario

Puntos fuertes y débiles							Punto fuerte o débil
		Puntuación		Puntuación de comparación	Diferencia	Valor crítico	
Indices	ICV	68	-	81	= -13	10,9	F o D
	IVE	97	-	81	= 16	9,07	F o D
	IRF	106	-	81	= 25	9,07	F o D
	IMT	62	-	81	= -19	8,67	F o D
	IVP	72	-	81	= -9	11,22	F o D
Pruebas	Semejanzas	5	-	6,5	= -1,5	3,16	F o D
	Vocabulario	3	-	6,5	= -3,5	3,44	F o D
	Cubos	10	-	6,5	= 3,5	3,16	F o D
	Puzles visuales	9	-	6,5	= 2,5	2,17	F o D
	Matrices	11	-	6,5	= 4,5	2,66	F o D
	Balanzas	11	-	6,5	= 4,5	2,05	F o D
	Dígitos	2	-	6,5	= -4,5	2,38	F o D
	Span de dibujos	4	-	6,5	= -2,5	2,38	F o D
	Claves	5	-	6,5	= -1,5	3,29	F o D
	Búsqueda de símbolos	5	-	6,5	= -1,5	3,22	F o D



Opciones de comparación de los índices

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios

MIP 405 / 5 81,0

Nivel de significación del valor crítico

Opciones de comparación de las pruebas

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales

MPE-P 65 / 10 6,5

Comparación entre índices/pruebas

Comparación		Puntuación 1		Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Indices	ICV-IVE	ICV 68	-	IVE 97	= -29	11,27	S o N
	ICV-IRF	ICV 68	-	IRF 106	= -38	11,27	S o N
	ICV-IMT	ICV 68	-	IMT 62	= 6	11,00	S o N
	ICV-IVP	ICV 68	-	IVP 72	= -4	12,78	S o N
	IVE-IRF	IVE 97	-	IRF 106	= -9	9,83	S o N
	IVE-IMT	IVE 97	-	IMT 62	= 35	9,53	S o N
	IVE-IVP	IVE 97	-	IVP 72	= 25	11,53	S o N
	IRF-IMT	IRF 106	-	IMT 62	= 44	9,53	S o N
	IRF-IVP	IRF 106	-	IVP 72	= 34	11,53	S o N
	IMT-IVP	IMT 62	-	IVP 72	= -10	11,27	S o N
Pruebas	Semejanzas-Vocabulario	S 5	-	V 3	= 1	2,93	S o N
	Cubos-Puzles visuales	C 10	-	PV 9	= 1	2,77	S o N
	Matrices-Balanzas	M 11	-	B 11	= 0	2,29	S o N
	Dígitos-Span de dibujos	D 2	-	SD 4	= -2	2,48	S o N
	Claves-Búsqueda de símbolos	CL 5	-	BS 5	= 0	3,04	S o N

Opciones de comparación de los índices

Nivel de significación del valor crítico

Grupo de referencia
Nivel de aptitud

Opciones de comparación de las pruebas

Nivel de significación del valor crítico

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario, balanzas). El paciente obtuvo un CIT de **76**, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **68**, se clasifica como **discapacidad leve**, estando en 3 rangos por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **97**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **106**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información, relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento inductivo y cuantitativo a fin de identificar y aplicar reglas.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **62**, se clasifica como **discapacidad leve**, estando en 3 rangos por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados,



implicando razonamiento, concentración, control mental; aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente.

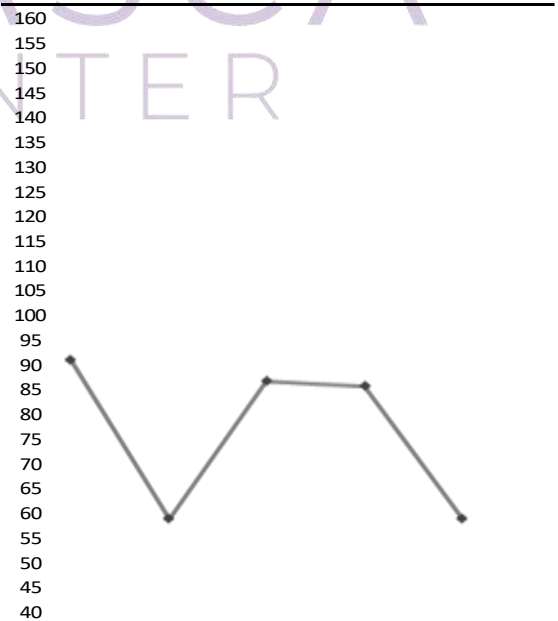
Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **72**, lo cual establece una capacidad **inferior**, estando 2 rangos por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

Análisis Secundario					
Suma de puntuaciones escalares					
Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			10	10	
Semejanzas				5	
Matrices			11	11	
Dígitos		2			2
Claves			5		5
Vocabulario				3	
Balanzas	11		11	11	
Puzles visuales			9		
Span de dibujos			4		4
Búsqueda de símbolos					5
Letras y números		4			
Aritmética	4				
Suma de puntuaciones escalares	15	6	50	40	16
	Raz. Cuantitativo	Mem. Trabajo auditivo	No verbal	Capacidad General	Competencia Cognitiva



IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	60	87	86	60



Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices					
Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	6	IMTA	60	0,4	56-71
No verbal	50	INV	87	19	81-94
Capacidad general	40	ICG	86	18	80-94
Competencia cognitiva	16	ICC	60	0,4	56-71

INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SECUNDARIOS

Razonamiento cuantitativo

El valor obtenido en IRC de 91 (entre 84-99) se sitúa en el percentil 27 y se clasifica como punto fuerte normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de Razonamiento cuantitativo refleja la capacidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente y comprender las relaciones cuantitativas. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió resolver mentalmente problemas aritméticos (Aritmética, Pe = 4) y en la otra se le pidió que observe una balanza a la cual le faltan pesas y seleccionar la opción que la mantiene equilibrada (Balanzas, Pe = 11). La variabilidad de los resultados en estas tareas es representativa, (es decir, su amplitud es mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Memoria de trabajo auditiva

El valor obtenido en IMTA de 60 (entre 56-71) se sitúa en el percentil 60 y se clasifica como punto débil normativo / Discapacidad leve con relación a otros niños de su edad y edad escolar.

El índice de Memoria de trabajo auditiva indica la aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió repetir una lista de cifras en el mismo orden o en orden inverso (Dígitos, Pe = 2) y en la otra se le solicitó repetir una combinación de letras y números leída previamente por el/la entrevistador/a (Letras y números, Pe = 4). La diferencia de los resultados entre las dos tareas no es grande (no llega a los 5 puntos), sin embargo el resultado en IMTA es una medida de por debajo del promedio esperado.

No verbal

El valor obtenido en INV de 87 (entre 81-94) se sitúa en el percentil 19 y se clasifica como punto débil normativo / Medio Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice no verbal puede interpretarse como una medida de aptitud intelectual general que reduce al mínimo la intervención del lenguaje expresivo. El INV está conformado por 6 puntuaciones escalares de pruebas que no requieren respuestas verbales: cubos (Pe = 10), matrices (Pe = 11), claves (Pe = 5), balanzas (Pe = 11), puzles visuales (Pe = 9) y span de dibujos (Pe = 4). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Capacidad general

El valor obtenido en ICG de 86 (entre 80-94) se sitúa en el percentil 18 y se clasifica como punto débil normativo / promedio Bajo con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice de capacidad general hace referencia a una estimación de la aptitud intelectual general menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el CI total. Involucra la capacidad de razonamiento abstracto y conceptual, razonamiento visoperceptivo y espacial y resolución de problemas verbales. El ICG es el resultado de 5 puntuaciones escalares: cubos (Pe = 10), semejanzas (Pe = 5), matrices (Pe = 11), vocabulario (Pe = 3) y balanzas (Pe = 11). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.



Competencia cognitiva

El valor obtenido en ICC de 60 (entre 56-71) se sitúa en el percentil 0,4 y se clasifica como 'punto débil normativo / Discapacidad leve con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de competencia cognitiva ofrece una estimación de la eficacia con la que se procesa la información durante el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento de nivel superior. El ICC es el resultado de 4 puntuaciones escalares: dígitos (Pe = 2), claves (Pe = 5), span de dibujos (Pe = 4) y búsqueda de símbolos (Pe = 5). La variabilidad de los resultados en estas tareas es igual (es decir, que su amplitud es menor a 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2)

Rango percentil	Clasificación
>84	Superior
84	Promedio alto
26-75	Normal promedio
16	Promedio bajo
5-9	Limite
<2	Muy bajo

Lenguaje			
Silabas	Puntaje	Percentil	
	6	26	NORMAL
Palabras	Puntaje	Percentil	
	6	2	ANORMAL
No palabras	Puntaje	Percentil	
	4	0,4	ANORMAL
Mide la articulación y la repetición de silabas - no palabras y palabras. Evalúa habilidades de pronunciación y articulación de diferentes fonemas producción del habla. Evalúa la estructura gramatical, evalúa recepción, comprensión y expresión del lenguaje oral, procesamiento audio fonológico y componente mnésico verbal.			
Lectura			
Oraciones	Puntaje	Percentil	
	6	2	ANORMAL
Lectura en voz alta	Puntaje	Percentil	
	12	0.4	ANORMAL



Evalúa la eficiencia lectora alcanzada por la persona evaluada, evalúa conversión grafema - fonema, identificación adecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación.

Comprensión			
Comprensión del discurso	Puntaje	Percentil	
	0	0,1	ANORMAL

Mide la habilidad comprensiva, análisis e inferencia.
 Evalúa la interpretación basado en los componentes de atención, memoria y lenguaje.

Escala de Autismo Infantil (C.A.R.S.) Madre.	
Preguntas de la prueba	
I. REFERENTE A LA GENTE	3
II. IMITACION	1
III. RESPUESTA EMOCIONAL	1
IV. USO DEL CUERPO	1
V. USO DE OBJETOS	1
VI. ADAPTACION AL CAMBIO	3
VII. RESPUESTA VISUAL	2
VIII. RESPUESTA AUDITIVA	2
IX. RESPUESTA AL SABOR, OLOR, TACTO Y USO	2
X. MIEDO O NERVIOSISMO	1
XI. COMUNICACION VERBAL	2
XII. COMUNICACION NO VERBAL	2
XIII. NIVEL DE ACTIVIDAD	1
XIV. NIVEL Y CONSISTENCIA DE LA RESPUESTA INTELECTUAL	1
XV. IMPRESIONES GENERALES	2
RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTISMO INFANTIL (C.A.R.S)	
RESULTADO: 25	NO AUTISMO



ADOS 2

Autism Diagnostic Observation Schedule, Segunda Edición

ALGORITMO DIAGNÓSTICO: MODULO 2: HABLA CON FRASES

Afectación social (AS)

Comunicación

Señalar	(A-6)	1	1	1
Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos	(A-7)	1	1	1

Interacción social recíproca

Contacto visual inusual	(B-1)	2	2	2
Expresiones faciales dirigidas a otros	(B-2)	2	2	2
Disfrute compartido durante la interacción	(B-3)	0	0	0
Mostrar	(B-5)	1	1	1
Iniciación espontánea de la atención conjunta	(B-6)	2	2	2
Características de las iniciaciones sociales	(B-8)	2	2	2
Cantidad de comunicación social recíproca	(B-11)	2	2	2
Calidad general de la relación	(B-12)	1	1	1

TOTAL AS

14

14

Comportamiento restringido y repetitivo (CRR)

Comportamientos restringidos y repetitivos

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases	(A-4)	1	1	1
Interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas	(D-1)	0	0	0
Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos	(D-2)	0	0	0
Intereses inusualmente repetitivo o comportamientos estereotipados	(D-4)	1	1	1

TOTAL CRR

2

2

PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL (AS + CRR)

16

16

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL AL RANGO DE PREOCUPACIÓN DEL ADOS-2		
Rango de preocupación	MENORES DE 5 AÑOS	5 AÑOS O MÁS
Autismo	10	9
Espectro autista	7	8
No TEA	0 a 6	0 a 7

La paciente se mostró colaboradora, muy cariñosa, es capaz de señalar para referirse a objetos y expresar un interés, pero sin la suficiente flexibilidad, ausencia de coordinación de la mirada con el señalamiento con poco contacto visual, es capaz de mirar objetos pero no al entrevistador o la madre, aun con apoyo no logra hacerlo, presenta poco uso espontáneo de gestos descriptivos como cepillado, gestos convencionales, gestos relacionados con estados de ánimos y emociones, aun con la modificación de la conducta del evaluador el contacto visual es limitado, en ocasiones con parpadeos constantes, no busca llamar la atención del evaluador o de la madre, no establece contacto visual para iniciar, terminar o regular una interacción social.

No dirige expresiones faciales apropiadas a los demás, puede dar muestra de disfrute con el examinador pero no lo incluye de forma espontánea en sus juegos; es capaz de mostrar juguetes u objetos de una manera parcial o inconsistente sin directriz, es capaz de responder preguntas e interacciones dirigidas pero no lo hace de manera espontánea.

No se orienta de forma clara hacia la madre o evaluador, puede iniciar una interacción entre los objetos pero no con los demás participantes, no expresa las emociones claras de los juguetes, las interacción tienen un tono bajo de voz, generalmente como consentido y disprosodico.

No hay una aproximación hay una iniciación espontánea de atención conjunta para dirigir la atención del adulto hacia un objeto que está fuera del alcance de la niña, las iniciaciones aun con apoyo son inapropiadas; muchas iniciaciones carecen de integración en el contexto o de naturaleza social.

La mayor parte de la comunicación está orientada a objetos, responder preguntas, imitando gestos de las acciones, (ecomimia), hay poca o ninguna reciprocidad o charla social.



La interacción a veces se ha sentido rara o poco natural, el comportamiento de la paciente ha parecido mecánico o ligeramente inapropiado para su edad biológica y educativa con un nivel de lenguaje expresivo por debajo de lo esperado.

Emplea frases de forma inusual junto con otro lenguaje espontáneo poco flexible, es importante señalar que durante la evaluación no se observó intereses sensoriales inusuales ni comportamientos de búsqueda sensorial, aunque la menor camina en punta de pies.

La menor logro con apoyo del evaluador mostrar aprendizajes rápidos en lo social, imitación, saludos, por ejemplo quiere estar abrazando a las personas sin conocer lo cual la coloca en riesgo de vulnerabilidad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto e inadecuada alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, inadecuadas respuestas en procesos relacionados la atención sostenida, selectiva (distractica) no acorde a su edad y escolaridad.

Presenta inadecuada atención auditiva, inadecuada búsqueda organizada de los estímulos, con dificultades en la velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico.

MEMORIA: Se identifica inadecuada capacidad para evocar información a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal, afectando los procesos de codificación, decodificación y evocación, lo que no favorece al aprendizaje significativo, tiene mayor desempeño manipulativo que verbal, lo cual obedece a las dificultades en comprensión verbal lo que limita el razonamiento y paso de la información.

Su capacidad de memoria o spam es de 4 sobre 9, observándose de forma incorrecta el efecto de primacía y recencia.

LENGUAJE: Existe inadecuada capacidad semántica, de vocabulario, poca capacidad de abstracción existe inadecuado seguimiento de instrucciones, inadecuada comprensión lo que limita la capacidad de entender y procesar información, en ocasiones la respuesta carece de consistencia, con marcada fuga de ideas, dislalia -rotacismo, lenguaje infantil para la edad, tono de voz bajo y disprosodico.

Lectura: Existe inadecuada eficiencia lectora, lo que quiere decir que existe alteración en la conversión grafema - fonema, con identificación inadecuada de las palabras para la recuperación de su pronunciación.



PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

Es importante resaltar que existe un bajo tono muscular, con dificultades en el equilibrio y seguimiento de secuencias motoras.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Paciente con inadecuada regulación conductual, poca inhibición, inadecuados procesos de análisis e inferencia, semejanzas, calculo, inadecuada planeación y ejecución de acciones, seguimiento de secuencia, le cuesta organizar la conducta hacia una meta determinada, se evidencio pobre flexibilidad cognoscitiva, poco automonitoreo, alteraciones en la memoria de trabajo, le cuesta mantener la información en línea de forma simbólica, pobre capacidad para las iniciaciones sociales, interacción, fluidez.

Paciente con **CIT de 76**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WISC V con **capacidad general intelectual inferior**, tres rangos por debajo de lo esperado, lo que establece marcadas dificultades para la adquisición de conceptos escolares y procesamiento cognitivo verbal, siendo una de las causas de bajo desempeño y problemas escolares, que establecen la necesidad de intervención y seguimiento de manera permanente con mediano grado de supervisión.

Las bajas puntuaciones en los indicadores de comprensión verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, atención, memoria verbal, establecen marcadas dificultad para la adquisición de nuevos aprendizajes y procesos de memoria a largo plazo sobre todo de contenido auditivo verbal lo cual puede generar alteraciones en el rendimiento académico e intelectual necesitando supervisión y monitoreo constante para realizar las tareas, especialmente las que demandan mayor esfuerzo cognitivo.

Se observa diferencia de 29 puntos en cuanto a la comprensión verbal 68 y habilidades visoespaciales de 97, lo cual establece un mayor desarrollo del hemisferio derecho, en comparación con el hemisferio izquierdo, con alta necesidad de rehabilitación como estrategia que permita compensar las dificultades.

Se observan respuestas dentro del promedio esperado en cuanto al procesamiento de la información con sus recursos innatos, del indicador de razonamiento fluido.106, lo que facilita en la paciente la capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata, es decir, de forma instintiva y con destreza.



La memoria de trabajo, 62 y velocidad de procesamiento, 72, se encuentran por debajo del promedio, con punto crítico de la memoria de trabajo, pudiendo generar dificultades en el manejo de la información a corto, plazo, en línea, rápida, efectiva y sin interferencia, lo que puede generar dificultades en la adquisición del aprendizaje, punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

El análisis comparativo de la página 3 permite analizar si existen diferencias significativas entre diversos pares de índices y pruebas del análisis primario y secundario. Esto es importante porque las diferencias significativas merecen un estudio detallado con independencia de cuál sea la aptitud intelectual general del sujeto.

Comparaciones entre índices primarios

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMAL: Comprensión verbal < Razonamiento fluido: implica debilidades en las aptitudes fluidas respecto a las cristalizadas.

ANORMAL: Comprensión verbal < Memoria de trabajo: implica un punto débil en la capacidad de identificar y registrar información en la memoria a corto plazo sobre el uso de estímulos verbales para la resolución de problemas.

ANORMAL: Comprensión verbal < Velocidad de procesamiento: indica un punto débil en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto al uso de los estímulos verbales para resolver problemas.

ANORMAL: Visoespacial < Velocidad de procesamiento: refleja debilidades en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo, aunque con adecuada capacidad de comprender y utilizar información visoperceptiva/visoespacial.

ANORMAL: Razonamiento fluido < Velocidad de procesamiento: sugiere capacidades superiores en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a las aptitudes para entender la relación entre la información visual y los conceptos abstractos.

ANORMAL: Memoria de trabajo < Velocidad de procesamiento: sugiere que posee más competencias en la toma de decisiones rápidas utilizando la información registrada en la memoria a corto plazo que en la manipulación de esta información.

Comparaciones entre índices secundarios

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMAL: Capacidad general < Competencia cognitiva: indica que las aptitudes que favorecen la eficacia del procesamiento cognitivo (memoria de trabajo y velocidad de procesamiento) pueden ser un punto débil en comparación con las aptitudes cognitivas de nivel superior (comprensión verbal, procesamiento visoespacial y razonamiento fluido).



ANORMAL: Memoria de trabajo < Memoria de trabajo auditiva: Establece dificultades en la presentación verbal de la información dificultando el funcionamiento de la memoria de trabajo respecto a la presentación visual.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PRUEBAS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

NORMAL: Cubos > Puzles visuales: indica que el aprendizaje procedimental, la resolución de problemas por ensayo-error, el feedback visual concreto y/o la integración visomotora favorecen el rendimiento en tareas en las que interviene el razonamiento visoperceptivo y espacial.

NORMAL: Matrices < Balanzas: sugiere que el razonamiento cuantitativo es un punto fuerte respecto al razonamiento inductivo.

ANORMAL: Claves < Búsqueda de símbolos: sugiere que el rastreo visual preciso es una debilidad respecto a la memoria asociativa y/o la velocidad grafomotora.

ANORMAL: Balanzas > Aritmética: implica mejor aptitud de razonamiento cuantitativo cuando el estímulo y la respuesta son visuales, en vez de verbales.

ANORMAL: Retención de dígitos < Letras y números: indica dificultades con la tarea de ordenar cadenas largas de números.

ANÁLISIS DE PROCESAMIENTO

Las puntuaciones de procesamiento ofrecen información más detallada de las aptitudes que intervienen en el rendimiento de la paciente en las distintas pruebas. Se realizan dos tipos de análisis, el primero orientado a los resultados obtenidos en las puntuaciones escalares en comparación con otros niños de su edad (interindividual), y el segundo dirigido a evaluar las puntuaciones de procesamiento del sujeto con relación a otras puntuaciones obtenidas (intraindividual).

Análisis de procesamiento interindividual

- Cubos sin bonificación por tiempo (Cs): Resultado en la prueba de diseño de cubos, sin conceder puntos extra por rapidez en la resolución de ítems. Es decir, que mide el proceso de orientación espacial sin tener en cuenta la velocidad en la que se responde a la tarea. Puntuación escalar obtenida: 4, categoría: Por debajo de lo esperado.
- Cubos parcial (Cp): Rendimiento en la prueba de diseño cubos, con bonificación de tiempo cuando se lo realiza rápidamente. Puntuación escalar obtenida: 1, categoría: Por debajo de la media. Esta puntuación sugiere debilidades en las tareas que exijan velocidad de respuesta.
- Dígitos en orden directo (Dd): Implica capacidad de almacenamiento en la memoria a corto plazo, ya que la tarea es repetir literalmente la secuencia que le fue leída previamente. Puntuación escalar obtenida: 2, categoría: Por debajo de lo esperado.
- Dígitos en orden inverso (Di): Involucra la utilización de la memoria de trabajo desde el inicio de la prueba, ya que debe repetir los dígitos que le fueron leídos de manera inversa (implica manipulación de la información, y no solo repetición). Puntuación escalar obtenida: 0, categoría: Por debajo de la media. Esta puntuación indica debilidades en las tareas que exijan el uso de la



memoria de trabajo.

- Dígitos en orden creciente (Dc): Además de la memoria de trabajo, interviene el conocimiento cuantitativo, ya que es necesario ordenar por su valor los dígitos que le fueron leídos previamente.

Puntuación escalar obtenida: 0, categoría: Por debajo de lo esperado.

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo Intelectual con alteración funcional del lenguaje, con nivel de apoyo grado 1, con un nivel intelectual, CI, inferior con alteraciones en comprensión, dislalia – rotacismo, disprosodia – acento como caricaturesco o rígido que pareciera como habla robótica, fufa de ideas – responde una cosa que no esta relacionada a lo que se pretende abordar, adecuada capacidad para responder con los recursos innatos sobre todo a nivel visual o manipulativo estableciendo un mayor desarrollo cuantitativo que verbal, lo cual puede compensar los problemas de comprensión verbal, adecuadas praxias, con tono muscular bajo, le cuesta manipular, mantener y realizar dos tareas al mismo tiempo de forma simbólica, la información se pierde, tarda mas de lo esperado en la realización de tareas que requieren la respuesta en un tiempo específico, existe limitación en las funciones ejecutivas, poco control atencional, problemas en atención sostenida continuos, tendencia a la labilidad atencional, baja tolerancia a la frustración, le cuesta mantener un hilo conversacional, es capaz de responder las preguntas pero no sigue la conversación, no es capaz de ser espontanea, poco contacto visual con parpadeos (estereotipias), camina en punta de pie – alteración propioceptiva, se aísla de forma recurrente, juega sin incluir a la madre o evaluador en el juego, su patrón de comportamiento se desvía que parece mecanizado y con poca facilidad de contacto, afecto plano, (tiene la tendencia a temer siempre la misma expresión), hiponimia, (no logra con facilidad hacer gestos cotidianos), ecomimia (repite movimientos sin que se le pida), existe selectividad al comer, (no come carne, pollo, no come ensaladas) - (hiporeactividad), existe muy baja reciprocidad socioemocional, no establece intercambio social, problemas en la sintaxis u orden gramatical, inadecuada pinza trípode, inadecuada posición sedente en silla con pelvis en neutro sin activación de tronco, afectando el desarrollo y desempeño en las esfera personal, social, familiar y educativa.

COMPRESIÓN VERBAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VISOESPACIAL: PROMEDIO

RAZONAMIENTO FLUIDO: PROMEDIO

MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN



IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

CODIGO CIE 11: 6A02.3 Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo Intelectual con alteración funcional del lenguaje, con nivel de apoyo grado 1.

CIT DE 76, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL INFERIOR, con necesidad de apoyo, supervisión.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos de comprensión verbal, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, atención, meta memoria, regulación de emociones y conducta.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde fonoaudiología, que permita abordar la comprensión verbal compleja, diferencias, analogías, fluidez verbal semántica y fonológica, comprensión de textos e historias, análisis y síntesis compleja, mejorar el discurso sintáctico, (lenguaje expresivo, articulatorio).

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde terapia ocupacional, que permita abordar la hiporresponsividad, modulación, regulación del impulso, control, selectividad de comida, caminar en punta de pie, parpadeos.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de dos meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, tono de voz, disprosodia, manejo de la frustración, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, habilidades sociales, fluidez, mayor interacción, espontaneidad.

Vincular a los padres mediante psicoeducación y sensibilización, como acompañamiento de la menor en sus dificultades, y orientarla en el manejo de estas.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes



estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Tener en cuenta que sus respuestas pueden carecer de consistencia, apoye desde lo visual o manipulativo.

Permítale recuperar los exámenes con talleres o repitiendo exámenes, sin dejar de exigirle, pero teniendo en cuenta sus limitaciones.

Trate de comprender el comportamiento, no se lo tome personal, está aprendiendo regularse.

Utilice un lenguaje claro, mensaje corto y apoyo en lo visual y auditivo.

Establezca rutinas claras, cronogramas visibles donde el aprenda que se debe hacer y cómo comportarse.

Coloque al lado del estudiante más sobresaliente para que modele las conductas positivas.

Dele un poco más de tiempo para las tareas.

Refuerce las conductas positivas.

Siente cerca al docente.

Permítale de vez en cuando salir a despejarse, no se tome su comportamiento personal, es algo que no puede evitar, enséñele con amor a regularse.

Haga del lugar de clases un lugar seguro, armonioso donde se sienta protegida, querida, celebre los pequeños logros.

Verifique que comprendido la consigna.

Evite criticar su comportamiento, ánimo, no se lo tome personal.

Permita que copie en casa lo que no termina en el colegio, pero son dejar de exigirle.

Coloque actividades de monitorea para mejorar la espontaneidad.




Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional: 123096

Certificado internacional en ADOS 2



PRASCA
CENTER

